

CONCENTRACIÓN MÁXIMA RECOMENDADA PARA FÁRMACOS EN INFUSIÓN INTRAVENOSA EN NEONATOLOGÍA

FÁRMACO	CONCENTRACIÓN MÁXIMA DILUCIÓN MG/ML	SOLUCIONES COMPATIBLES	DILUCIÓN INFUSIÓN (hrs) (min)	ESTABILIDAD DILUCIÓN		PRECAUCIONES / COMPONENTES / INCOMPATIBILIDAD
				DILUCIÓN (HRS) TEMPERATURA AMBIENTE	REFRIGERACIÓN	
AMINOGLUCÓSIDOS						
AMIKACINA	2.5 a 10 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	20 a 30 min	24 hrs (A menos de 25°C)	NO	Riesgo de nefrotoxicidad (reversible) y Ototoxicidad permanente
GENTAMICINA	10 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 a 120 min	NO	NO	Se puede aplicar IM. Riesgo de nefrotoxicidad (reversible) y Ototoxicidad permanente
CEFALOSPORINAS						
AMPICILINA	30 a 100 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	5 a 15 min	1 h (A menos de 25°C)	NO	Incompatible: Amikacina, fluconazol, metoclopramida. La administración rápida puede producir crisis convulsivas.
CEFALOTINA	20 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 min	6 hrs (A menos de 25°C)	48 hrs	Monitoreo de la función hepática y renal. No IM muy dolorosa
CEFAZOLINA	20 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 min	24 hrs	10 días	No administrar IV la vía IM contiene lidocaína
CEFEPIMA	100 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 min	24 hrs	7 días	Incompatible: Aciclovir, Metoclopramida, Vancomicina, Aminofilina, Anfotericina B
CEFOTAXIMA	50 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	10-30 min	24 hrs	7 días	Incompatible: Bicarbonato de sodio, Fluconazol y Vancomicina
CEFOXITINA	40 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 min	18 hrs	7 días	Sobredosis: taquipnea, palidez, acidosis metabólica e hipotonía
CEFTAZIDIMA	50 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 min	12 hrs	3 días	Incompatible: DFH, Fluconazol, Vancomicina.
CEFTRIAXONA	40 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 min	48 hrs	10 días	Incompatible: En soluciones con calcio. Puede causar hiperbilirrubinemia. Puede aparecer un color oscuro después de la reconstitución; sin embargo, se conserva la potencia.
CEFUROXIMA	30 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 min	24 hrs	48 hrs	Incompatible: Fluconazol, Vancomicina, Amikacina
PENICILINAS						
DICLOXACILINA	10 mg/ml	SF 0.9%	30 min	4 hrs	24 hrs	No diluir con gluc.5% o 10% se solidifica
PENICILINA G SÓDICA CRISTALINA	Neonato: 50 000 UI Niños y adultos: 100 000 UI	Gluc 5% - SF 0.9%	15 a 30 min	6 hrs (A menos de 25°C)	7 días	Riesgo de reacción alérgica Incompatible: Anfotericina B, Heparina, metilprednisolona, fenitoína, aminofilina.
PIPERACILINA /TAZOBACTAM	Piperacilina 40 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 min	24 hrs	48 hrs	Incomp: Aciclovir, Amikacina, anfotericina B, dobutamina y vancomicina, caspofungina, ganciclovir y gentamicina. Vigilar extravasación
ANTIBIÓTICOS (GLUCOPÉPTIDOS)						
VANCOMICINA	5 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	1 a 2 hrs	2 hrs (A menos de 25°C)	4 días	"Síndrome del niño rojo" en infusión rápida. Diluir hasta 10 mg/ml en pacientes con restricción de líquidos
TEICOPLANINA	10 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 min	NO	24 hrs	Incompatible en la solución con Amikacina

Elaboró: EEP. Rosa Rebolledo Próspero. JUBILADA IMSS. HGZ No. 71 Lic. "B.C.L." Veracruz, Ver. Elaboradas Mayo de 2015. Act. Noviembre 2018. Actualizada Enero 2024

Bibliografía: - Micromedex Neofex Essentials 2020 / - Sole A. Zenobi PC. Neofarms (SIBEN). 11 ed. México, D.F. 2014. / - E Young T.Mangum B. Neofex Manual de Drogas Neonatológicas Edit. Panamericana 188 Edición 2006. / - <https://cima.aemps.es/cima/oi/01/2024>
- Thomson. Diccionario de especialidades farmacéuticas. 49 ed. México 2003. / - App Neofarms Siben 2016 / - <https://www.medicamentospim.com/Home/Medicamento/a/1/citado enero de 2024> / - <https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pedimedicum> [citado enero de 2024]

CONCENTRACIÓN MÁXIMA RECOMENDADA PARA FÁRMACOS EN INFUSIÓN INTRAVENOSA EN NEONATOLOGÍA

 FÁRMACO	CONCENTRACIÓN MÁXIMA DILUCIÓN MG/ML	SOLUCIONES COMPATIBLES	DILUCIÓN INFUSIÓN (hrs) (min)	ESTABILIDAD DILUCIÓN		PRECAUCIONES / COMPONENTES / INCOMPATIBILIDAD
				DILUCIÓN (HRS) TEMPERATURA AMBIENTE	REFRIGERACIÓN	
OTROS (ANTIFÚNGICOS, FLUOROQUINOLONAS, ANTIVIRALES, SULFONAMIDAS, CARBAPENÉMICOS Y BACTERICIDAS)						
ACICLOVIR	7 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	1 h	24 hrs	NO. Se precipita	Incompatible con NPT. La extravasación puede causar necrosis
AMOXICILINA/ ÁC.CLAVULANICO	10 mg/ml	SF 0.9%	30 min	4 hrs	12 hrs	Incompatible: SG 5% y 10%, ciprofloxacino, Amikacina, bicarbonato
ANFOTERICINA B	0.1 mg/ml	Gluc 5%	2 a 6 hrs	24 hrs	7 días	Proteger de la luz. Incompatible con: SF y ABD (se precipita) Evite rápida administración (pueden producirse hipotensión, hipopotasemia, arritmias y shock)
CASPOFUNGINA	0.5 mg/ml	SF 0.9%	1 h	24 hrs (A menos de 25°C)	48 hrs	No utilizar diluyentes que contengan glucosa. Incomp: aciclovir, Ceftriaxona, furosemida, heparina, piperacilina/tazobactam y NPT
CICLOSPORINA	1 mg/2ml	Gluc 5% - SF 0.9%	2 a 6 hrs	24 hrs	NO. Se solidifica	Contiene etanol y aceite de ricino polioxiethylado
CIPROFLOXACINO	Directo 2 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	60 min	24 hrs (A menos de 30°C)	NO. Se cristaliza	Incompatible: Aminofilina, clindamicina
CLINDAMICINA	6 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 a 60 min	24 hrs	NO	Oral (palmitato) se reconstituye con ABD (75 mg/5 ml) dura 14 días. No refrigerar
CLORANFENICOL	100 mg/ml	Gluc 5%	10 a 20 min	12 hrs	NO	Prohibido. "Sx. niño gris"
FLUCONAZOL	Directo 2 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	15 min	24 hrs / VO 14 días	NO. Se precipita	Contraindicado en pacientes con cisaprida (riesgo de arritmias graves) hepatotoxicidad.
GANCICLOVIR	10 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	1 h	24 hrs (15 - 25°C)	NO. Se precipita	Incompatible con NPT, aztreonam, Cefepime y piperacilina-tazobactam
IMIPENEM/CILAST	5 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	20 a 30 min	4 hrs	24 hrs	Incompatible con NPT, se desactiva en pH alcalino o ácido
LEVOFLOXACINO	Directo 5 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 a 60 min	8 hrs	NO	Reacciones dermatológicas y fototoxicidad. No mezclar con heparina
LINEZOLID	Directo 2 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 a 120 min	24 hrs / VO 21 días	NO	Color amarillo no altera potencia. Mantener en la envoltura de aluminio
MEROPENEM	50 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 min	3 hrs	13 hrs	Incompatible: Aciclovir. Anfotericina B, metronidazol. Se puede diluir en 20 mg/ml
METRONIDAZOL	5 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 a 60 min	24 hrs	NO. Se cristaliza	Se puede diluir el de 200mg en 8mg/ml. Incompatible: aztreonam y meropenem. NO utilice equipos que contengan aluminio (p. ej., agujas, cánulas) que podrían entrar contacto con la solución del fármaco.
MICAFUNGINA	0.5 a 1 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	1 h	24 hrs (A menos de 25°C)	24 hrs	No agitar y proteger de la luz. Incompatible: Dobutamina, midazolam y vecuronio. Concentraciones superiores a 1.5 mg/ml (hasta 4mg/ml) debe administrarse a través de una vía central
TMT/SMT	TMT 1.5 mg/ml	Gluc 5%	1 h	6 hrs	NO. Se cristaliza	No recomendable en RN antes de los 28 días de vida
VORICONAZOL	2 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	1 a 2 hrs	6 hrs	24 hrs	Incompatible con soluciones de bicarbonato sódico y NPT. No bolos. No se han establecido la seguridad y la eficacia en pediátricos menores de 2 años
ZIDOVUDINA	4 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 a 60 min	24 hrs	48 hrs	No aplicar IM. Incompatibilidad: hemoderivados, albúmina y meropenem

Elaboró: EEP. Rosa Rebolledo Próspero. JUBILADA IMSS. HGZ No. 71 Lic. "B.C.L." Veracruz, Ver. Elaboradas Mayo de 2015. Act. Noviembre 2018. Actualizada Enero 2024

Bibliografía: - Micromedex Neofex Essentials 2020 / - Sole A. Zenobi PC. Neofarms (SIBEN). 11 ed. México, D.F. 2014. / - E Young T.Mangum B. Neofex Manual de Drogas Neonatológicas Edit. Panamericana 188 Edición 2006. / - <https://cima.aemps.es/cima/oi/01/2024>
- Thomson. Diccionario de especialidades farmacéuticas. 49 ed. México 2003. / - App Neofarms Siben 2016 / - <https://www.medicamentospim.com/Home/Medicamento/a/1/citado enero de 2024> / - <https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pedimedicum> [citado enero de 2024]

CONCENTRACIÓN MÁXIMA RECOMENDADA PARA FÁRMACOS EN INFUSIÓN INTRAVENOSA EN NEONATOLOGÍA

OTROS						
FÁRMACO	CONCENTRACIÓN MÁXIMA DILUCIÓN MG/ML	SOLUCIONES COMPATIBLES	DILUCIÓN INFUSIÓN (hrs) (min)	ESTABILIDAD DILUCIÓN		PRECAUCIONES / COMPONENTES / INCOMPATIBILIDAD
				DILUCIÓN (HRS) TEMPERATURA AMBIENTE	REFRIGERACIÓN	
ADENOSINA	300 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	1 a 2 seg. Bolos	NO	NO	Debe realizarse lo más proximal posible, y seguido de un lavado rápido con suero fisiológico.
AMINOFILINA	1 a 5 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	20 a 30 min	24 hrs	NO	NO administrar con FC mayor a 180 lpm. Incompatible: Cefepime, dobutamina y ceftriaxona.
AMIODARONA	2 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 a 60 min	24 hrs	NO	NO bolos. Pref. En vena central. Incompatible: Aminofilina, bicarbonato de sodio. NO en "Y" con NPT
BUMETANIDA	125 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	2 min	NO	24 hrs	Incompatibilidad: Dobutamina y midazolam
BUPRENORFINA	60 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	2 min	24 hrs	NO	Puede producir sx de abstinencia y depresión respiratoria en el neonato.
BUTILIOSCINA	2 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	10 a 15 min	24 hrs	NO	Efectos adversos: visión borrosa, taquicardia, retención urinaria.
CITRATO DE CAFEINA	10 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	30 min	24 hrs (A menos de 25°C)	24 hrs	NO IM, SC, IT NI intraperitoneal. NO administrar con FC mayor a 180 lpm. Incompatible: Aclolvir, furosemida, lorazepam, nitroglicerina y oxalicina. Solución oral 10 mg/ml de base de cafeína (Nota: 10 mg de base de cafeína = 20 mg de citrato de cafeína). Se puede preparar una solución oral alternativa de cafeína disolviendo 2.5 g de polvo anhidro de cafeína en 250 ml de agua, para una concentración final de 10 mg/ml. La sol. permanece estable durante 4 semanas en refrigeración. Almacenada a baja temperatura se cristaliza, pero se disuelve a temperatura ambiente sin perder potencia. No congelar.
DIGOXINA	50 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	10 a 20 min	24 hrs	NO	NO administrar con FC menor a 100 lpm. NO administrar IM
DFH (FENITOÍNA)	10 mg/ml	SF 0.9%	30 min	4 a 6 hrs	NO. Se cristaliza	Causa hipotensión en infusión rápida. Necrosis al extravasarse. Diluir con SF o ABD para que no se cristalice, con lavado de la vía pre y post-administración. Hasta en 5 mg/ml se puede diluir.
DEXAMETASONA	1 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	20 a 30 min	24 hrs	NO	Incomp: con vancomicina y Midazolam. Vacunas de virus vivos: aumenta riesgo de infección
DIFENHIDRAMINA	5 mg/ml	SF 0.9%	15 min	14 días	NO	La administración muy rápida puede provocar mareo. No administrar. en RN y prematuros. IM no diluir
DOBUTAMINA	3 a 5 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	Infusión cont.	24 hrs	7 días	Con preferencia por vía central o venas periféricas de grueso calibre. Evitar administrar por vena umbilical cuando no se haya cerrado el ductus venoso. NO ADMINISTRAR POR ARTERIA UMBILICAL. NO Bolos
DOPAMINA	50 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	Infusión cont.	24 hrs	24 hrs	Igual que la dobutamina
FUROSEMIDA	2 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	15 a 30 min	24 hrs	NO. Se precipita	Incomp: Amikacina, dobutamina, dopamina y midazolam. Hasta 10mg/ml
FENOBARBITAL	20 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	10 a 15 min	30min	NO	Contiene propilenglicol potencialmente tóxico. Necrosis si se extravasa
FENTANILO	10 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	15 a 30 min	NO	24 hrs	Causa depresión respiratoria grave. NO usar con buprenorfina, nalbuphina
GLUCONATO DE CALCIO	50 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	20 a 60 min	24 hrs	NO. Se solidifica	Monitorización cardíaca, FC menor a 100 lpm no administrar. La extravasación puede causar necrosis
HIDROCORTISONA	1 a 5 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	20 a 30 min	24 hrs	3 días	Incomp: Amikacina, Aminofilina, anfotericina B. EA arritmias y bradicardia
ISOPROTERENOL	20 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	Infusión cont.	24 hrs	NO	Conservar las ampollas en la nevera y protegido de la luz. NO usar si la solución está en color rosado o pardo. Incomp: bicarbonato y furosemida
KETAMINA	50 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	Bolo en 2 min e infusión continua	24 hrs	NO	Puede producir depresión respiratoria o apnea
KETOROLACO	3 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	5 min	24 hrs	NO refrigerar	Contraindicado: aumenta el sangrado. Tto IV no más de 2 días. NO en neonatos
LIDOCAINA	1 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	5 min	24 hrs (A menos de 25°C)	NO	Incomp: fenitoína. Se puede administrar en bolo e infusión

Elaboró: EEP. Rosa Rebolledo Próspero. JUBILADA IMSS. HGZ No. 71 Lic. "B.C.L." Veracruz, Ver. Elaboradas Mayo de 2015. Act. Noviembre 2018. Actualizada Enero 2024

Bibliografía: - Micromedex Neofax Essentials 2020 / - Sole A. Zenobi PC. Neofarma (SIBEN). 11 ed. México, D.F. 2014. / - E Young T.Mangum B. Neofax Manual de Drogas Neonatológicas Edit. Panamericana 188 Edición 2006. / - <https://cima.semps.es/cima/cit.01/2024>
- Thomson. Diccionario de especialidades farmacéuticas. 49 ed. México 2003. / - App Neofarma Siben 2016 / - <https://www.medicamentospim.com/Home/Medicamento/a/s/citado enero de 2024> / - <https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pedimedicum> [citado enero de 2024]

CONCENTRACIÓN MÁXIMA RECOMENDADA PARA FÁRMACOS EN INFUSIÓN INTRAVENOSA EN NEONATOLOGÍA

OTROS						
FÁRMACO	CONCENTRACIÓN MÁXIMA DILUCIÓN MG/ML	SOLUCIONES COMPATIBLES	DILUCIÓN INFUSIÓN (hrs) (min)	ESTABILIDAD DILUCIÓN		PRECAUCIONES / COMPONENTES / INCOMPATIBILIDAD
				DILUCIÓN (HRS) TEMPERATURA AMBIENTE	REFRIGERACIÓN	
METADONA	0.5 mg/ml	SF 0.9%	Infusión cont.	24 hrs (A menos de 25°C)	NO	Bolo en 2 min. Dosis excesivas causan depresión respiratoria. IV solo temporal.
METAMIZOL (DPS)	50 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	5 a 10 min	24 hrs	NO	Admón. Lenta, si no causa hipotensión y choque. No a niños <12 meses
METILPREDNISOLONA	10 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	15 min	48 hrs	NO	Reconstituir el vial con el disolvente que acompaña la presentación. puede producir hipotensión, arritmia y muerte súbita en la administración rápida. Hasta 30 mg/ml
METOCLOPRAMIDA	200 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	15 min	24 hrs	NO	Contraindicado en RN. Incompatible: ampicilina, gluc. calcio. Puede causar mareo
MIDAZOLAM	1 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	10 min	24 hrs	NO	Depresión respiratoria e hipotensión a la administración rápida en bolo.
MILRINONA	200 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	15 a 60 min	24 hrs	NO	Incompatibilidad: Furosemida e imipenem-cilastatina
MORFINA	100 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	15 a 30 min	24 hrs	NO	Efecto adverso: depresión respiratoria pronunciada. Retención de orina. Incompatibilidad: Cefepime, fenitoína. Hasta 500 mcg/ml
NALBUFINA	1 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	5 a 10 min	24 hrs	NO	Precauciones: Sedación, depresión respiratoria, euforia, frío.
NITROGLICERINA	50 a 100mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	Infusión cont.	48 hrs	7 días	Se adsorbe a plásticos. No recomendada en neonatos. Hasta 400 mcg/ml
NITROPRUSIATO DE SODIO	200 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	Infusión cont.	24 hrs (Proteger de la luz)	NO	Hipotensión y taquicardia graves. Con Tto. Prolong. se puede desarrollar toxicidad por cianuro. Una extravasación puede causar espasmo y necrosis de tejidos. Proteger de la luz. Cambio de color tornándose azul, verde o rojo intenso indica inactivación. Incomp: Amiodarona
NOREPINEFRINA	100 mcg/ml	Gluc 5%	Infusión cont.	24 hrs (Proteger de la luz)	NO	(Noradrenalina). La extravasación puede causar necrosis. Proteger de la luz
OCTEOTIDE	10 a 25 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	15 a 30 min	NO	14 días	Refrigerar y proteger de la luz. No calentar artificialmente. Hasta 1 mg/ml
ONDANSETRON	0.2 a 1 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	15 min	24 hrs	NO	Monitorearse a los pacientes con signos sugestivos de oclusión intestinal.
OMEPRAZOL	0.4 a 4 mg/ml	Su diluyente/SF/G5	20 a 30 min	4 hrs (A menos de 25°C)	12 hrs	La experiencia parenteral en niños es limitada. Diluir con su diluyente
PANCURONIO	Directo 2mg/ml 160 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	Bolos 10 seg Infusión cont.	48 hrs	48 hrs	EA: Puede desarrollarse hipoxemia por ventilación mecánica insuficiente y deterioro de la mecánica respiratoria. Taquicardia, Aumento de la salivación.
PANTOPRAZOL	0.4 a 0.8 mg/ml	Su diluyente/SF/G5	15 a 30 min	24 hrs	NO	Datos limitados en neonatos. EA: taquicardia, Stevens-Johnson, diarrea.
PROPOFOL	Directo 10mg/ml 2 mg/ml	Gluc 5%	Bolos Infusión cont.	6 hrs (A menos de 25°C)	12 hrs	Agitar antes de usar. No tiene efecto analgésico. En bolo puede causar apnea y bradicardia. No usar en neonatos.
PROPRANOLOL	100 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	10 a 15 min	24 hrs	NO	EA: Bradicardia, espasmo, bronquial e hipoglucemia. Incomp: con bicarbonato sódico.
RANITIDINA	1 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	15 a 20 min	48 hrs	NO	Prohibido. En prematuros sepsis bacteriana y fúngica, ECN
VECURONIO	400 mcg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	Bolo 1 min	24 hrs diluido con ABD	24 hrs dil. G5%	Reconst. el vial con el disolvente incluido. Precaución: relajante neuromuscular. Hasta 1 mg/ml
VITAMINA K ₁	1 mg/ml	Gluc 5% - SF 0.9%	1 mg/min.	NO. Se oxida con el O ₂	NO	(Fitomenadiona). Proteger de la luz. Incompatible con dobutamina y fenitoína. NO conservar diluido. En prematuros puede causar hiperbilirrubinemia

META 3 internacional: MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO. Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-2012, Etiquetado de medicamentos

NOMBRE DEL ELECTROLITO	DOSIS/AMPOLLETA	DOSIS/ML	COLOR
Cloruro de Potasio 14.9%	20 mEq/10 ml	2 mEq/ml	ROJO
Gluconato de Calcio 10%	1 gr/10 ml	100 mg/ml	AMARILLO
Fosfato de Potasio 15%	20 mEq/10 ml	2 mEq/ml	NARANJA
Bicarbonato de Sodio 7.5%	8.9 mEq/10 ml	0.89 mEq/ml	AZUL
Sulfato de Magnesio: 10%	1 gr/10 ml	100 mg/ml	VERDE
Concentrado de sodio 17.7%	30 mEq/10 ml	3 mEq/ml	BLANCO

Elaboró: EEP. Rosa Rebolledo Próspero. JUBILADA IMSS. HGZ No. 71 Lic. "B.C.L." Veracruz, Ver. Elaboradas Mayo de 2015. Act. Noviembre 2018. Actualizada Enero 2024

Bibliografía: - Micromedex Neofax Essentials 2020 / - Sole A. Zenobi PC. Neofarma (SIBEN). 11 ed. México, D.F. 2014. / - E Young T.Mangum B. Neofax Manual de Drogas Neonatológicas Edit. Panamericana 188 Edición 2006. / - <https://cima.semps.es/cima/cit.01/2024>
- Thomson. Diccionario de especialidades farmacéuticas. 49 ed. México 2003. / - App Neofarma Siben 2016 / - <https://www.medicamentospim.com/Home/Medicamento/a/s/citado enero de 2024> / - <https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pedimedicum> [citado enero de 2024]